

# Kliendist kodanikuks ehk personaalne taastumine vaimse tervise valdkonnas



**Külli Mäe, Anna Toots**

*Heaolu ja Taastumise Kool*



Kui vaatame inimese isiklikku teekonda elukaarel, siis on selle osadeks alati ka kriisid ja neist taastumine. Kriiside üheks mõjuteguriks võib olla ka vaimse tervise olukorra kriitiline ja/või pikaaegne halvenemine. Artikkel tutvustab taastumist vaimse tervise valdkonnas ning sekkumisi, mis aitavad inimestel sellel teekonnal edasi liikuda.

Kõige tuntum personaalse taastumise definitsioon pärineb Bill Anthonylt. Tema järgi on taastumine sügavalt isiklik ja unikaalne protsess, mis muudab inimese hoiakuid, väärtusi, tundeid, eesmärke, oskusi ja/või rolle. See võimaldab inimesel elada rahuldust pakkual, lootusrikkal ja panustaval viisil ka siis, kui haigus seab talle oma piiranguid. Taastumine tähendab ka elule uue tähenduse ja eesmärgi andmist (Anthony 1993). Personaalse taastumise mõtestamisel on rõhk lootusel, identiteedil ja isiklikul vastutusel (Andresent jt 2003).

Sotsiaalvaldkonna töötajad peavad oskama kriise märgata ja ennetada, inimesi tuleb toetada kriisidega toimetulekul, neist õppimisel ning lootuse ja elu mõtte leidmisel. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanne on pakkuda hoolekandeteenuseid, mis inimeste

toimetulekut eri rollides toetavad.

Miks on oluline rääkida praegu personaalsest taastumisest, kas selles on midagi uut? Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekande alusmudel on juba alates 1990. aastate lõpust isikukeskne (vt nt „Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis” 2000/2001). Leiame, et praegusel ajal, kui on käimas erihoolekandeteenuste sisu ümbermõtestamine, tuleks siiski astuda veel üks samm edasi. Väitest, et meil on isikukesksed teenusepakettid, ei piisa selleks, et inimesed tunneksid end tõesti ühiskonnas osalevatena. Inimeste personaalset taastumist toetavate teenuste osutamiseks on vaja vastavasisuliselt teadmisi, väärtuseid, hoiakuid, mis avalduksid meie töös ja suhtlemises abivajajatega.

Selle kirjutisega tahame soodustada arvamuste vahetust sotsiaaltöötajate ja vaimse

tervise spetsialistide vahel, et suurendada mõistmist ja lugupidamist vaimse tervise probleemidega inimeste suhtes. Artiklis kasutatud näited pärinevad autorite töökoogemusest ning 2016.–2017. a Tervise Arengu Instituudis toimunud koolituse „Kliendist kodanikuks vaimse tervise valdkonnas” tagasisidest ja arutlustest. Mõtteviisi tutvustus on aga kindlasti mõjutatud 18.–20. septembril Nottinghami ülikoolis toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Refocus on recovery 2017” („Rõhuasetus taastumisele 2017”) kuuldust.

### Kas taastumist saab õppida?

Osa erihoolekandetöötajaid väidab, et väga vähesed nende kliendid on õppimisvõimelised. Nad on kogenud, et taastumisvõtete koolitused hooldekodudes või päevakeskustes hoopis raskendavad tegevusjuhendajate tööd, sest kliendid muutuvad ärevaks, neil tekivad asjatud lootused asuda iseseisvalt elama ja leida tööd ning liigne stress, mis võib halvendada nende vaimset tervist ning põhjustada koguni kriisi. Meilt on isegi küsitud, kas asjatuid unistusi õhutavad koolitused on vastutustundlikud.

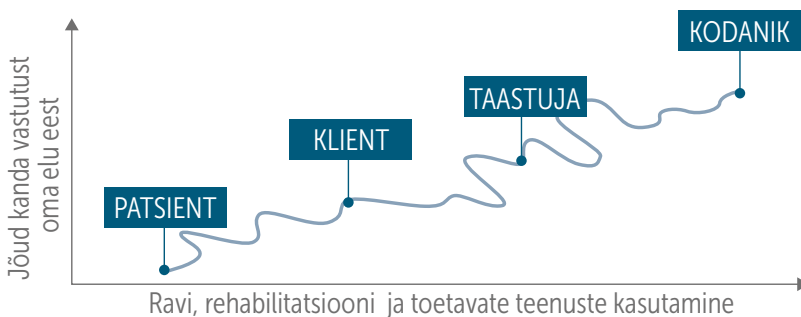
Paljud töötajad siiski tunnetavad, et taastumise õpetamine on võimalik ja vajalik. Näiteks väidavad nad, et sellest peale, kui

nad ise teavad rohkem taastumist toetava hoolekande põhimõtetest (näiteks tänu CARE metoodika koolitustel ja koviesiooni osalemisele), on töö erihoolekandes ja/või vaimse tervise probleemidega klientidega palju kergem.

Üks CARE metoodika koolitusel osaleja kirjeldas seda nii: „*Olen kliendi kaasteeline tema isiklikul teekonnal. Ma ei saa kiiremini edasi liikuda, kui tema on valmis oma valikuid tegema. Samas näen, et kogukonnas on palju võimalusi, mida kliendile pakkuda; tean, milliseid uksi avada ning sobival hetkel saan aktiivsemalt muutusi soodustada. Koos saame võimalusi uurida. Tunnen, et usaldus laseb mul paljudes loovates rollides olla kliendi kõrval – võrdväärselt koos tegutsedes jagame nii rõõme kui muresid*” (Koolituse tagasiside 2017). Wilken ja Hollander (2017) ütlevad, et kui inimest takistavad halb väljendusoskus, emotsioonide või suhetega seotud piirangud, siis ei ole temaga lihtne kontakti saada, dialoogini jõudmisest rääkimata. See nõuab tihti peale palju aega. Tugiteenuse osutaja peab sellisel juhul olema vastupidav ja loominguline.

### Rolli muutus

Heaolu ja Taastumise Kooli taastumiskursustel selgitame joonise abil (vt joonis 1)



**Joonis 1.** Kliendist kodanikuks (autorite koostatud Soome Vaimse Tervise Keskliidu taastumiskursuse juhendaja käsiraamatu põhjal)

**Tabel 1.** Kliinilise ja personaalse taastumise põhijooned (Slide ja Wallace 2017 põhjal).

| Kliiniline taastumine on ...                        | Personaalne taastumine on ...                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulemus või seisund                                 | Protsess                                                                                     |
| Jälgitav, objektiivne                               | Subjektiivne                                                                                 |
| Seda hindab spetsialistist ekspert                  | Seda saab hinnata vaimse tervise probleeme kogev inimene ise – ta on enda taastumise ekspert |
| Kindla tähendusega, ei sõltu konkreetsest inimesest | Iga inimese jaoks erineva tähendusega, kuigi esineb sarnaseid aspekte                        |

üsna alguses, kuidas inimene saab liikuda patsiendi-kliendi rollist teadliku taastuja rolli.

Selgitame joonist järgnevalt. Haigestudes tunneb inimene end tihti patsiendina ja selles rollis hakkavad tavaliselt teda nägema ka teised. Taastumise käigus suhtumine oma haigusesse vähehaaval muutub. Inimene liigub taastudes „haige” ja „patsiendi” rollist taastuja identiteedi kaudu elu teistesse rollidesse. Seda protsessi kirjeldades selgitame ka psühhiaatrilise ravi, rehabilitatsiooni ja erihoelekansteenustega seotud mõisteid. Inimene võib taastumise ajal vajada ravi, osaleda rehabilitatsioonis ja kasutada tegevusjuhendaja toetust.

Enamasti kulub minevikus kogetu seljataha jätmiseks palju aega ning see nõuab pingutust nii taastujalt kui ka tema juhendajalt. Palju abi on kogemusettekannete kuulamisest ja kogemusnõustajate eeskujust.

## Ravi ja rehabilitatsioon

Taastumine ei ole sama, mis psüühikahäirest paranemine. Ravi ja taastumine on eri asjad, kuigi ravi võib olla taastumisprotsessi üks olulisemaid elemente. Personaalne taastumine puudutab inimest ja tema elu, see on võimalik igaihe puhul. Tõsi, igal inimesel ei ole taastumiseks vajalikku tahet või valmisolekut. Igaüks valib ise oma tee. Lähedased

inimesed ja elukutselised aitajad saavad julgustada ja anda lootust. Lootuse ja elule mõtte leidmine on taastumisteenikonnal väga olulised. Personaalse ja kliinilise taastumise erinevusi selgitab tabel 1.

Personaalsel ja kliinilisel taastumisel on erinev fookus. Arusaam kliinilisest taastumisest on kujunenud välja spetsialiste korraldatud uuringute ja praktika põhjal, seevastu arusaam personaalsest taastumisest on välja kasvanud vaimse tervise teenuste kasutajate liikumisest, taastumist saab hinnata ainult vaimse tervise probleemiga elav inimene ise. Ta on ise oma taastumise ekspert. Enda elule tähenduse andmine on keeruline, siin ei saa rakendada must-valget lähenemist. Kõige tähtsam on inimese hinnang oma elule. (Wilken ja Hollander 2017)

Taastumiskeskne mõtteviis hõlmab ka jõustamise ning puuetega inimeste õiguste, kaasamise ja rehabilitatsiooni filosoofiat.

Paljude riikide uuemad strateegilised dokumendid toetavad üleminekut personaalset taastumist toetavale hoolekandele ja seda palju laiemalt kui ainult erihoelekanandes. Hea on tõdeda, et ka Eesti vaimse tervise strateegias 2016–2025 on taastumist ja rehabilitatsiooni väärtustav peatükk.

Suuremates vaimse tervise keskustes on meil personaalset taastumist toetatud juba 1990. aastate lõpust, selle teenistuses on psüh-

hohariduslikud ja ka lähedastele mõeldud programmid, toetatud töölerakendamine, erihoolekande ja rehabilitatsiooni võimaluste integreerimine. Viimasel viiel aastal on palju räägitud erihoolekande reformist ja kliendikesksest teenustedisainist. Korraldatakse personaalse taastumise võtete koolitusi, oskusõppemooduleid ja positiivsel psühholoogial põhinevaid programme<sup>1</sup>.

## Spetsialistide roll

Taastumiskeskne mõtteviis tähendab üleminekut diagnoosi- ja probleemikeskselt lähenemiselt tuguvustele põhinevale ja eesmärkidele orienteeritud lähenemisele. Taastumislööd näitavad, et taastumise käigus on inimesele eelkõige olulised saatusekaaslased, eneseabi, sõbrad ja perekond. Kuid ka spetsialistidel on endiselt oluline roll taastujate toetamisel – nad aitavad selgust saada seadustes, juhendavad grupitööd jpm.

Riskihindamine ja -juhtimine on ka taastuva mõtteviisi puhul vaimse tervise teenuste loomulikud osad. Spetsialistid tegelevad varajase märkamise ja kriiside ennetamisega. Seejuures on oluline vahet teha riskidel, mida on vaja vähendada, ja nendel, mida inimestel on õigus kogeda.

Teenuseid pakutakse lähtudes inimese olukorrast, taastumine on sügavalt isiklik protsess. Üsna tulemuslikuks sekkumiseks on taastumiskursused, kus osalejad koostavad oma taastumislugu. Selle käigus räägitakse pigem võimalustest ja tugevustest, mitte probleemidest ja piirangutest.

Taastumist toetavate sekkumiste valikul on abiks CHIME raamistik (Slide ja Wallace 2017). Inglisekeelne akronüüm CHIME moodustub viiest valdkonnast, igaühes on omad sekkumisviisid. Nimetame järgnevalt

neid, mille efektiivsus on uuringutega kinnitust leidnud.

CHIME raamistik ja võimalikud sekkumised:

1. Staatus-seotus (*connectedness*): toetatud tööle rakendumise programm, mis võimaldab tööalast hõivatust ja tähenduslike suhete loomist. Suhete loomist ja hoidmist toetavad sekkumised, kogemusnõustamine, eneseabi-grupid, stigmat vähendavad koolitused ja info.
2. Motivatsioon, lootus ja optimism (*hope and optimism*): haiguste juhtimise strateegiad, positiivsete suhete edendamine, kogemusnõustamine, heaolu taastamise tegevusplaan (WRAP).
3. Eneseteadlikkus/identiteet (*identity*): taastumislööd, narratiivne teraapia.
4. Eneseabi ja selle tähendus (*meaning, purpose*): spirituaalsuse ja religiooni ühendamine psühholoogiliste teraapiatega, isiklike eesmärkide seadmine ja töö nende saavutamiseks.
5. Tugevused, jõustamine (*empowerment*): kriisiplaan, jagatud otsuste tegemine, tugevustepõhine juhtumikorraldus, kogemusnõustajate kaasamine teenuste arendusse ja teenuste osutamisse.

## Taastumiskool – hea näide taastumisele keskendunud hoolekandest

Taastumiskool ehk *recovery college* on uudenduslik kooslomele tuginev koolitusmudel, mida saab rakendada igas kogukonnas. Eesmärk on õpetada vaimse tervise probleemidega inimestele oskusi ja anda teadmisi, mis aitavad neil oma haiguse ja eluga paremini toime tulla. Teadmisi jagatakse ka nende sugulastele ja sõpradele ning spetsialisti-

<sup>1</sup> vt nt *Positive Psychotherapy for Psychosis: A Clinician's Guide and Manual* 2016.

dele. Mudel levib kiiresti kogu maailmas (vt nt Suurbritannias Nottingham Recovery College, ImROC, Austraalias Mind Recovery College, Eestis Heaolu ja Taastumise Kool).

Järgitakse põhimõtet, et spetsialistide, kogemusnõustajate ja õppijate (vaimse tervise probleemidega inimeste) koostöö on igati võrdväärne ja seda tehakse nii koolituste ja töötubade planeerimisel kui ka läbiviimisel.

Kõigil avatud kursustel osalemine on vabatahtlik. Kursustel omandatakse igapäevaelus tarvilikke oskusi, kõneldakse vaimse tervise probleemidest jpm, see toetab osalejate iseisivsust ning kogukonna ja ühiskonna elus osalemist.

Koostöös saab välja arendada ka kursuseid mitmete erialade spetsialistidele: näiteks õpetajatele, kes töötavad erivajadustega lastega, politseinikele jne. 

### Viidatud allikad

- Andresen, R., Oades, L., Caputi, P.** (2003). The experience of recovery from schizophrenia: towards an empirically validated stage model. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 37, 586–594.
- Anthony, W. A.** (1993). Recovery from mental illness. The guiding vision of the mental health system in the 1990s. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16, 11–23.
- Hollander, D., Wilken J. P.** (2017). Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARE metoodika abil. Tallinn: DUO kirjastus.
- Slade, M., Wallace, G.** (2017). Recovery and Mental Health. Raamatus: Slade, M., Oades, L., Jarden A. (Toim.), Wellbeing, Recovery and Mental Health Cambridge: Cambridge University Press. 24–34.